АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ · ВІДКРИТІ СТАТИСТИЧНІ ДАНІ

Медичні кадри України

Кадрове забезпечення та оплата праці

Україна · дані за 2025–2026 роки

ЛІКАРІ
152 336
станом на кінець 2025 року

СЕРЕДНІЙ МЕДПЕРСОНАЛ
230 682
станом на кінець 2025 року

ЛІКАРІВ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ
23,5%
від загальної кількості лікарів

ОПЛАТА В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я
20 590 грн
середнє за січень–вересень 2026 року

Короткий підсумок

Дослідження виявляє поєднання кадрових ризиків і недостатньо конкурентної оплати праці в українській медицині. Майже чверть лікарів досягла пенсійного віку, а середня оплата праці в охороні здоров'я нижча за загальноукраїнський рівень і суттєво поступається провідним секторам економіки.

Мета та запитання дослідження

Оцінити чисельність і вікову структуру медичних кадрів, розглянути підготовку нових фахівців, зіставити оплату праці в медицині з іншими сферами України та окремими країнами Європи. Основне запитання: чи створюють кадрові та зарплатні показники ризики для здатності системи охорони здоров'я зберігати й оновлювати персонал?

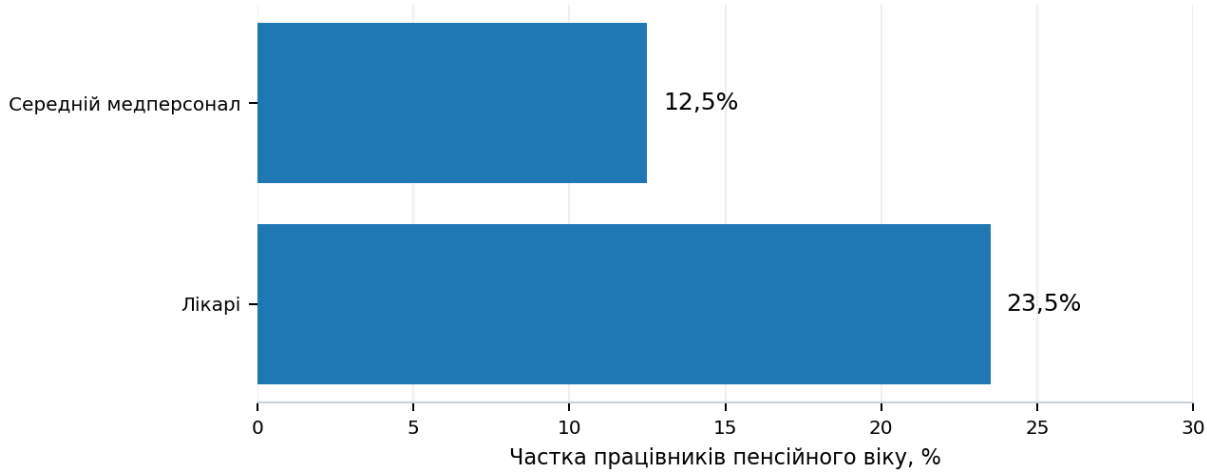
Як читати результати

У звіті розмежовано три різні типи показників: чисельність персоналу, середню зарплату в галузі та зарплати, запропоновані у вакансіях. Вони описують різні аспекти системи й не є взаємозамінними.

01 · КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Чисельність і вікова структура

Станом на кінець 2025 року в досліджених даних обліковувалося 152 336 лікарів та 230 682 працівники середнього медичного персоналу. Водночас вікова структура свідчить про ризик поступового вибуття частини кадрового потенціалу.



Частка працівників пенсійного віку

Пенсійного віку досягли 35 749 лікарів (23,5%) і 28 716 працівників середнього медичного персоналу (12,5%). Отже, ризик оновлення кадрів особливо помітний серед лікарів: майже кожен четвертий належить до цієї вікової групи.

Регіональний вимір

Розподіл медичних працівників між регіонами нерівномірний. У сільській місцевості працювали 12 440 лікарів (8,2% від загальної кількості) та 31 720 працівників середнього медичного персоналу (13,8%). Ці показники вказують на потребу окремо враховувати територіальну доступність кадрів.

Аналітичний висновок

Кадрову стійкість не можна оцінювати лише загальною кількістю працівників. Важливі також вік фахівців і їхній розподіл між містами та сільською місцевістю. Саме ці чинники впливають на можливість забезпечити безперервність медичної допомоги.

02 · ПІДГОТОВКА НОВИХ ФАХІВЦІВ

Оновлення кадрового потенціалу

За наявними в дослідженні даними, у вересні 2024 року в інтернатурі перебували 15 035 осіб. У 2024 році на інтернатуру було зараховано 7 348 осіб: 2 974 — за державним замовленням і 4 374 — на контрактній основі.

Показник	Кількість
Особи в інтернатурі (вересень 2024)	15 035
Зараховано до інтернатури у 2024 році	7 348
З них — державний бюджет	2 974
З них — контракт	4 374

Найбільші напрями державного замовлення у 2024 році

Спеціальність	Кількість
Внутрішні хвороби	422
Загальна практика — сімейна медицина	364
Хірургія	324
Анестезіологія та інтенсивна терапія	290
Медицина невідкладних станів	183
Педіатрія	182

Підготовка лікаря — тривалий процес, який для окремих спеціальностей може наближатися до дев’яти років. Тому кадрові втрати не можна швидко компенсувати лише збільшенням набору студентів або інтернів: важливо також утримувати фахівців, які вже мають досвід.

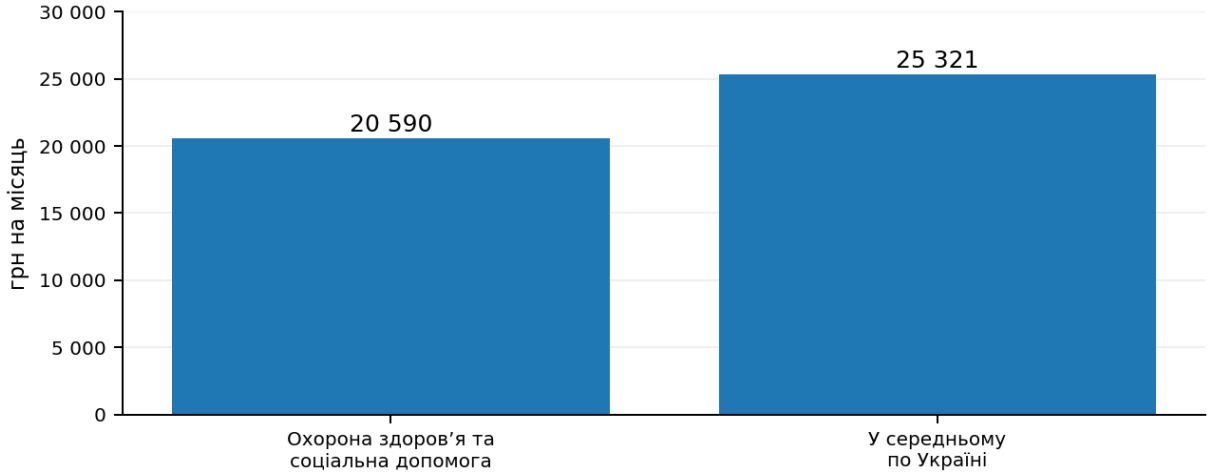
Практичний акцент

Планування кадрової політики має поєднувати прогноз потреби за спеціальностями й регіонами, підтримку молодих лікарів на початку кар’єри та заходи для збереження досвідченого персоналу.

03 · ОПЛАТА ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Медицина серед інших сфер економіки

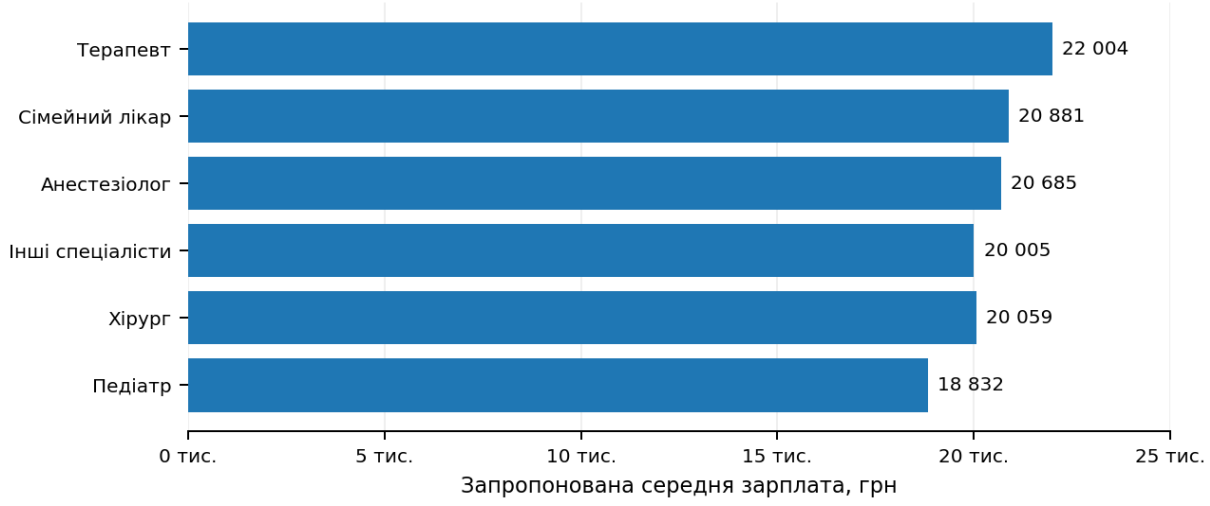
За січень–вересень 2026 року середня заробітна плата в охороні здоров’я та соціальній допомозі становила 20 590 грн, тоді як середня по Україні — 25 321 грн. Отже, галузевий показник дорівнював 81,3% загальноукраїнського рівня.



Місце серед дев’яти категорій

Порівняння дев’яти основних категорій економічної діяльності показало, що охорона здоров’я перебуває майже наприкінці рейтингу. За результатами дослідження, оплата праці тут майже вдвічі нижча, ніж у категоріях із найвищими показниками. Це підкреслює слабку конкурентну позицію галузі на внутрішньому ринку праці.

Зарплати у вакансіях за лікарськими спеціальностями

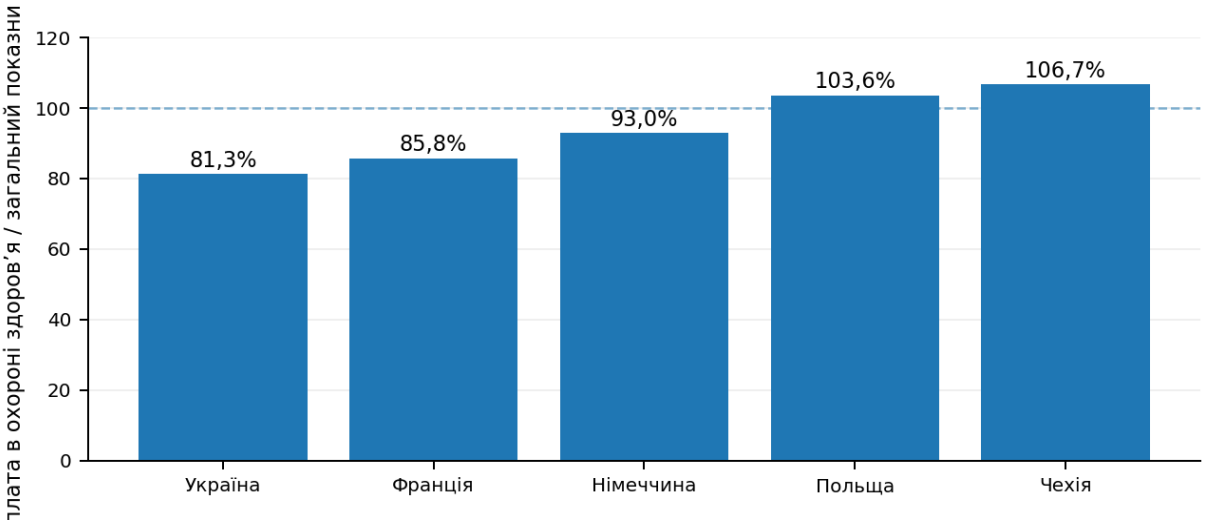


Дані Державної служби зайнятості відображають запропоновану роботодавцями зарплату у вакансіях, а не фактичні доходи всіх лікарів. У вибірці найнижча середня пропозиція була для педіатрів (18 832 грн), найвища — для терапевтів (22 004 грн).

04 · МІЖНАРОДНЕ ПОРІВНЯННЯ

Відносна оплата праці в медицині

Для міжнародного зіставлення використано співвідношення середньої оплати праці в охороні здоров’я та загального галузевого показника всередині кожної країни. Такий підхід дає змогу порівняти відносне становище медицини в національній економіці, не зіставляючи напряму різні рівні цін і валют.



Україна має найнижчий показник серед п’яти досліджуваних країн — 81,3%. У Франції він становить 85,8%, у Німеччині — 93,0%, у Польщі — 103,6%, у Чехії — 106,7%. У Польщі та Чехії оплата в охороні здоров’я перевищує загальний галузевий показник.

Що означає цей результат

В Україні оплата праці в охороні здоров’я відстає від загального рівня економіки сильніше, ніж у кожній із розглянутих країн. Це не означає, що абсолютні зарплати можна безпосередньо порівнювати: українські дані охоплюють 2026 рік, європейські — 2022 рік. Порівнюється саме внутрішнє співвідношення між галуззю та загальним показником у кожній країні.

Методологічне обмеження

Дані Eurostat — річні валові заробітки за 2022 рік для вибраних секторів і підприємств із чисельністю 10 та більше працівників. Категорія охорони здоров’я включає також соціальну роботу. Порівняння не враховує паритет купівельної спроможності.

05 · ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Що показало дослідження

Отримані результати вказують на взаємопов’язані проблеми: значну частку лікарів пенсійного віку, нерівномірний територіальний розподіл кадрів і недостатньо конкурентну оплату праці в охороні здоров’я.

1. Кадрове забезпечення. Потрібні заходи для залучення молодих медичних працівників, підтримки фахівців на початку кар’єри та утримання досвідчених кадрів, особливо в регіонах із нижчою забезпеченістю.

2. Оплата праці в Україні. Варто підвищувати конкурентоспроможність оплати праці медиків з урахуванням кваліфікації, складності, обсягу та відповідальності виконуваної роботи.

3. Фінансування медичних закладів. Доцільно вдосконалювати механізми фінансування спеціалізованої допомоги, забезпечувати прозорий розподіл коштів усередині лікарень і справедливий зв’язок винагороди з реальною роботою медичних працівників.

4. Підготовка фахівців. Кадрове планування має враховувати тривалість підготовки лікарів, прогноз потреби за спеціальностями та регіонами, а також необхідність збереження вже підготовлених кадрів.

5. Моніторинг. Доцільно регулярно відстежувати чисельність і вікову структуру персоналу, вакансії, запропоновану оплату праці та регіональні дисбаланси, щоб коригувати кадрову політику на основі даних.

Сьогоднішнє ставлення держави до медичних працівників визначатиме, чи матиме Україна достатньо фахівців для лікування людей завтра. Це не просто питання зарплат — це питання стратегічної стійкості держави та здоров’я всього суспільства.

Джерела даних

Центр громадського здоров’я МОЗ України (форма №17); Державна служба статистики України; Державна служба зайнятості України; Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО); Eurostat.

Інструменти: Python, Pandas, Excel, Power BI, GitHub. Аналітичний проєкт виконано на основі відкритих статистичних даних. Результати відображають показники та періоди, зазначені в методологічних поясненнях; вони не замінюють комплексного аудиту системи охорони здоров’я.